

共同生活援助・介護サービス包括型

障害者グループホーム事業

定員20名 ／ RC造1棟(全26室) ／ 日立市(茨城県)

供給不足の市場に、安全性で差別化して参入する

茨城県日立市において障害者グループホーム(共同生活援助・介護サービス包括型)を開設・運営する。RC造3階建て1棟・全26室。
うち居室20室は全て1K仕様(浴室・トイレ付き)・定員20名とし、残る6室は共用スペース5室+スタッフルーム1室(夜勤5名待機可)に充てる。

20名

定員(全室個室・居室20室)

3.9億円

必要初期費用(概算)

530万円

月間売上(満室時)

83万円

月間利益(利益率15.7%)

85%

損益分岐(17人/20人)

約25年

投資回収(満室維持時)

112%

GH需要達成率(供給不足)

本提案:必要初期費用 約3.9億円(建設関連・開業 2億7,570万円+運転資金 1億1,000万円)の資金計画 — 調達スキーム(出資・金融機関借入・公的融資の組合せ)は協議の上決定

26万人の精神科入院患者

日本には約26万人の精神科入院患者がいる。その入院費用は1人あたり月額約44万円。

年間で約1.4兆円の医療費が投入されており、この公費負担は高齢化と精神障害者の増加により今後さらに膨らむ。

約26万人

精神科入院患者数

月44万円

入院1人あたり月額費用

1.4兆円/年

精神科医療費(推計)

出典:厚生労働省「患者調査」、日本精神科病院協会データ

だから何？ 公費負担が増え続ける。構造的な解決策が必要

18万人が退院できない

26万人のうち約18万人は「社会的入院」と呼ばれる状態にある。医学的には退院可能だが、退院後に住む場所がないため入院を継続している。住居さえあれば地域で暮らせる人々が病院に留め置かれている。

約18万人

社会的入院(退院可能だが退院先がない)

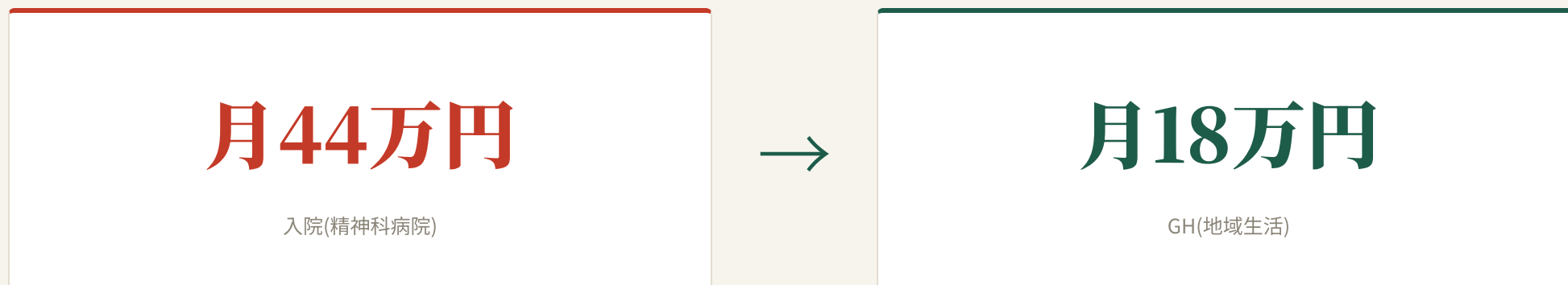
「住む場所があれば、今すぐ退院できる」——これが18万人の現実

だから何？ 住む場所があれば今すぐ動ける。GHはその受け皿

入院 月44万円 vs GH 月18万円

統合失調症の入院費:1日14,640円 × 30日 = 月額約44万円。グループホームの公費負担:月額約18万円。

差額は月26万円 × 12ヶ月 = **年間309万円/人の公費削減**。



1人が退院してGHに移行するだけで、年間309万円の公費が浮く。

だから何？ 1人移行で年309万円の公費削減。20名で年6,200万円

国の「入院から地域へ」政策

法改正 精神保健福祉法改正(2024):退院支援の義務化・地域移行の促進

整備目標 第7期障害福祉計画:GH整備を数値目標で明記

日立市 「新規参入の促進」を計画に明記

報酬改定 地域移行支援の加算を段階的に引き上げ

自治体責務 退院後の住居確保・支援体制の整備を義務付け

政策の方向性とビジネスの方向性が完全に一致している。

行政が「やってほしい」と言っている事業を行う。

だから何？ 政策追い風で行政が協力的。逆風になるリスクが低い

グループホームとは

障害者グループホーム(共同生活援助)は、障害のある方が地域の中で共同生活を営む住居。

「介護サービス包括型」は食事・入浴・排泄等の介護を事業所内のスタッフが直接提供する。

居住支援 1K個室(浴室・トイレ付き・鍵付き)+共用リビング

生活支援 食事提供・服薬管理・金銭管理支援

日中活動 就労準備・日中活動の送り出し

相談支援 生活全般の相談・退院後の地域定着

夜間支援 夜勤スタッフ常駐(最大5名/晩)の24時間体制

「ホテルのようにきれいに。施設っぽくしない。自立を目指す家」

だから何？ **利用者に何を提供するのが分かる**

日立障害福祉圏—— 6病院・1,303床

日立障害福祉圏は日立市・高萩市・北茨城市の3市で構成。圏域内に精神科病院6院・合計1,303床が存在する。**全院を営業訪問済み。**

市	人口(R5)	障害者数	GH利用者(R5)
日立市	167,501人	12,944人(7.73%)	339人
高萩市	約25,000人	約1,508人	52人
北茨城市	約39,000人	—	60人

日立市の障害者構成比7.73%は県平均4.9%を大幅に上回る

だから何？ 参入ルートは既に確立されている(全院訪問済み)

需要分析 —— 実績が見込みを常に上回る

日立市のGH需給は実績が見込量を一貫して上回る(平均達成率112%)。市は「利用希望者も大幅に増加しており、更なるサービス提供体制の整備が必要」と明記。

手帳等区分	H30年度	R5年度	増減率	年度	見込量	実績	達成率
身体障害者手帳	5,599	5,894	+5.3%	R3	264人	302人	114.4%
療育手帳	1,534	1,706	+11.2%	R4	286人	320人	111.9%
精神障害者手帳	1,136	1,564	+37.7%	R5	308人	339人	110.1%
精神通院医療	2,613	2,998	+14.7%	R8見込	454人	—	—
合計	11,654	12,944	+11.1%				

精神障害+37.7%の急増。R8見込454人はR5実績比+115人の増加余地 —— 当施設20名はその17%に過ぎない

だから何？ 空室リスクは構造的に低い。需要が供給を常に上回る

なぜRC造 × 夜勤最大5名か

初期費用と夜間人件費を「あえて」厚くする設計。紹介元(病院・相談支援)が最も重視する「夜間の安全」と「受入力」に応えることで、紹介が集まる構造をつくる。

01

耐火・耐震のRC造

夜間火災・災害リスクに構造で対応。スプリンクラー・自火報に耐火構造を重ね、6項口基準を上回る安全水準。法定耐用47年の長期資産。

02

夜勤 最大5名/晩

基本3名・支援度に応じ最大5名まで増強できる体制。増強時は夜間支援等体制加算の区分も上がり収支影響は限定的。病院が安心して紹介できる退院先となる。

03

全室個室・ホテル品質

全室1K仕様(浴室・トイレ付き)の鍵付き完全個室20室。家賃3万円/月と障害基礎年金の範囲で入居できる負担設定。「施設っぽくしない」住環境で選ばれ、長期入居につながる。

安全と受入力の差別化は、「空室リスクの低減」と「夜間支援等体制加算の確実な算定」として財務に還元される

だから何？ **コスト増は戦略。紹介が集まり、稼働と単価で回収する**

支援ネットワーク

この事業は単独で始めるのではない。既に構築済みの支援ネットワークがある。

医療 圏域6病院を全院営業訪問済み。退院候補者の紹介ルート確立

相談支援 スペース空・いわき相談支援事業所と連携。入居候補者の直接紹介

行政 日立市障害福祉課との関係構築。市計画に「新規参入促進」明記

前計画実績 前計画期間中に6事業所が新規参入。行政の支援実績あり

地域 日立市は障害者構成比7.73%(県平均4.9%超)で高い社会的関心

だから何？ **今すぐ動けるチームがある。ゼロからの立ち上げではない**

開設スケジュールと認可プロセス

GHの開設には茨城県の指定が必要。日立市が「新規参入の促進」を計画に明記しており、事前相談は実施済み。**2026年内の着工、2028年1月のPhase 1受入開始を目標とする。**

時期	マイルストーン
2026年 7～8月	土地確定・実施設計(基本設計と並行して短縮)・日立市事前協議(実施済み)
2026年 9～10月	建築確認申請・消防法6項口対応協議・茨城県への指定事前協議
2026年 11～12月	着工(2026年内・RC造3階建て・工期約11ヶ月)
2027年 10～11月	竣工・消防検査
2027年 12月～2028年 1月	県指定取得・職員採用/研修・内覧会
2028年 1月	Phase 1 受入開始(10名)→ 以後ユニット単位で段階受入

※2026年内着工は土地の早期確定と設計・審査の並行進行が前提。確定時期により1～3ヶ月前後する可能性がある

だから何？ 開設までの道筋が時系列で明確。不確定要素は少ない

RC造3階建て1棟・全26室

居室20室は全て1K仕様(各室に浴室・トイレ完備)とし、共同生活住居2ユニット(10名・10名)で構成(1住居あたり定員10名以下の基準に適合)。
残る6室は共用スペース5室とスタッフルーム1室に充て、20名分の調理に対応する大型キッチンを用意する。延床面積:約800㎡。

設備	仕様
居室 20室	全室1K仕様・各室に浴室/トイレ・鍵付き・ベッド・エアコン
ユニット	2住居(10名/10名・1～2階)
共用スペース 5室	リビング・ダイニング・相談・多目的等
スタッフルーム 1室	夜勤最大5名が同時待機できる広さ(仮眠対応)
キッチン	20名分の調理に対応する大型キッチン
浴室・トイレ	各居室に完備(1K仕様)+介助対応の共用浴室
構造	RC造・耐火構造(法定耐用年数47年)
面積	延床約800㎡(約40㎡/人)
家賃設定	3万円/月(補足給付対象・年金内で入居可能)

消防設備(6項目)	1棟合計
スプリンクラー(水道連結型)※自火報とセット整備	600万円
自動火災報知設備	200万円
その他+予備費	200万円
消防設備 合計	1,000万円

「ホテルのようにきれいに。
施設っぽくしない。自立を目指す家」

だから何？ 何をどこに建てるか仕様が明確。RC造で夜間の防火安全性も強化

地域トップ水準の処遇で人材を確保する

介護サービス包括型の人員基準を満たす常勤6名+パート2名+夜勤体制。給与は地域相場を大きく上回る水準に設定し、人材の確保・定着を最優先する(処遇改善加算の上位区分取得の原資にもなる)。夜間は基本3名・最大5名/晩。

職種	人数	形態	月給	地域相場(目安)
管理者兼サビ管	1名	常勤	500,000円	30～35万円
世話人	3名	常勤	230,000円	18～20万円
世話人	1名	パート	120,000円	10万円
生活支援員	2名	常勤	240,000円	21万円
夜勤スタッフ	基本3名・最大5名/晩(ローテ)		パート	16,000円/回
事務員	1名	パート	110,000円	10万円
役員報酬	1名	—	300,000円	※金額は調整可能

人件費+役員報酬:月額3,640,000円(満室時・月間支出の81.4%) ※夜勤は基本3名/晩×16,000円×30日=1,440,000円。旧給与体系比 月+77万円

だから何？ 高処遇は人材戦略。採用力と定着率が支援の質と稼働を支える

月次収支計画(満室時)

■ 収入

区分	月額
基本報酬(区分3中心・一部区分4)	1,800,000円
夜間支援等体制加算 ※	1,500,000円
処遇改善加算等(加算Ⅰ相当)	500,000円
実費(家賃3万+食費3万+光熱水費1.5万)	1,500,000円
月間収入 合計	5,300,000円

■ 損益

月間利益	830,000円
年間利益	9,960,000円
利益率	15.7%

■ 支出

区分	月額
人件費(日中:常勤6+パート2・高水準給与)	1,900,000円
夜勤人件費(基本3名/晩×16,000円×30日)	1,440,000円
役員報酬(1名)	300,000円
施設維持費(RC造1棟)	250,000円
運営費	580,000円
月間支出 合計	4,470,000円

実費収入が月間収入の28.3%を占め、報酬改定リスクへのバッファとなる。基本報酬は高水準人材により区分3中心(一部区分4)の受入を前提に9万円/人月で計上。

※夜間支援等体制加算は夜勤3～5名運用を想定した保守的概算。前提と感度分析は次頁参照

だから何？ 月収530万・月利益83万。高処遇でも黒字が成立する

収支の前提条件と感度分析

収支計画の主要前提を明示し、前提が崩れた場合の耐性を検証。最大の変動要因は夜間支援等体制加算と稼働率。

■ 主要前提

項目	前提
基本報酬	区分3中心(一部区分4)・90,000円/人月
夜間支援等体制加算	夜勤3～5名運用・告示単位の約7割で概算
処遇改善加算等	50万円/月(加算Ⅰ相当・高水準賃金が要件を充足)
実費収入	家賃3万+食費3万+光熱水費1.5万=7.5万円/人月
給与水準	サビ管50万円/月ほか地域トップ水準+役員報酬30万円/月
稼働	開設後約18ヶ月で満室(段階受入)

■ 感度分析

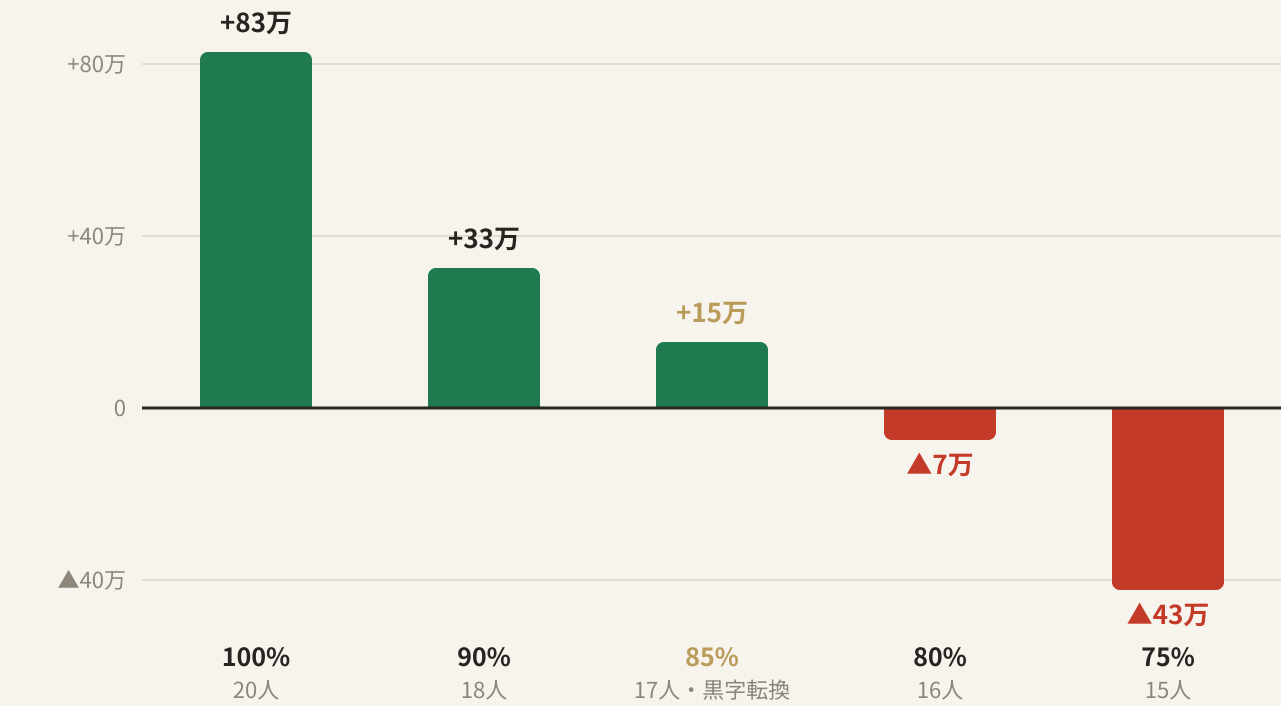
前提の変動	影響	評価
夜間加算 ▲30%	月間利益 83万 → 38万円	BEP 85%→約95%。満室時は黒字維持
賃金上乘せ+役員報酬(月77万)を立ち上げ期凍結	BEP 85% → 75%	立ち上げリスクを大幅圧縮
稼働率90%で定常	年間利益 394万円	満室維持が回収の必須条件
建築費 +10%	初期費用 +2,230万円	回収期間 +約2～3年

加算の算定区分は指定申請時に確定後、数値を更新。賃金上乘せ分と役員報酬は業績連動(満室安定後に満額)とする選択肢を推奨

だから何？ 主要前提を開示。単一的前提が崩れても赤字転落しない構造

損益分岐 —— 稼働率85%で黒字

稼働率別の月間損益(高水準給与・役員報酬込み・夜勤3名運用時)



投資回収シナリオ

回収対象:建設関連+開業費用 = 2億7,570万円

シナリオ	稼働率	年間利益	回収期間
満室維持	100%	996万円	約28年
標準	95%(19人)	695万円	約40年
保守的	90%(18人)	394万円	約70年

回収期間は事業利益ベース。土地・RC造建物(取得原価ベース約2.6億円・法定耐用47年)の**資産価値は別途残存**。
高処遇モデルは**満室維持が前提**。賃金上乘せ・役員報酬(月77万円)を業績連動とすればBEP75%まで低下し、下振れ耐性を確保できる。

だから何？ 高処遇モデルは満室運営が前提。業績連動化と資産残存が下支え

段階開設モデル — Phase 1 → 2

建物はRC造1棟のため一括建設とし、受入をユニット(階)単位で段階化する。
人員・夜勤体制を稼働に合わせて立ち上げ、運営リスクを逡減する。

Phase	受入ユニット	累計定員	夜勤配置	月間収入(概算)
Phase 1	1階ユニット(10名)	10人	2名/晩	約265万円
Phase 2	+2階ユニット(10名)	20人	3名/晩(最大5名)	約530万円

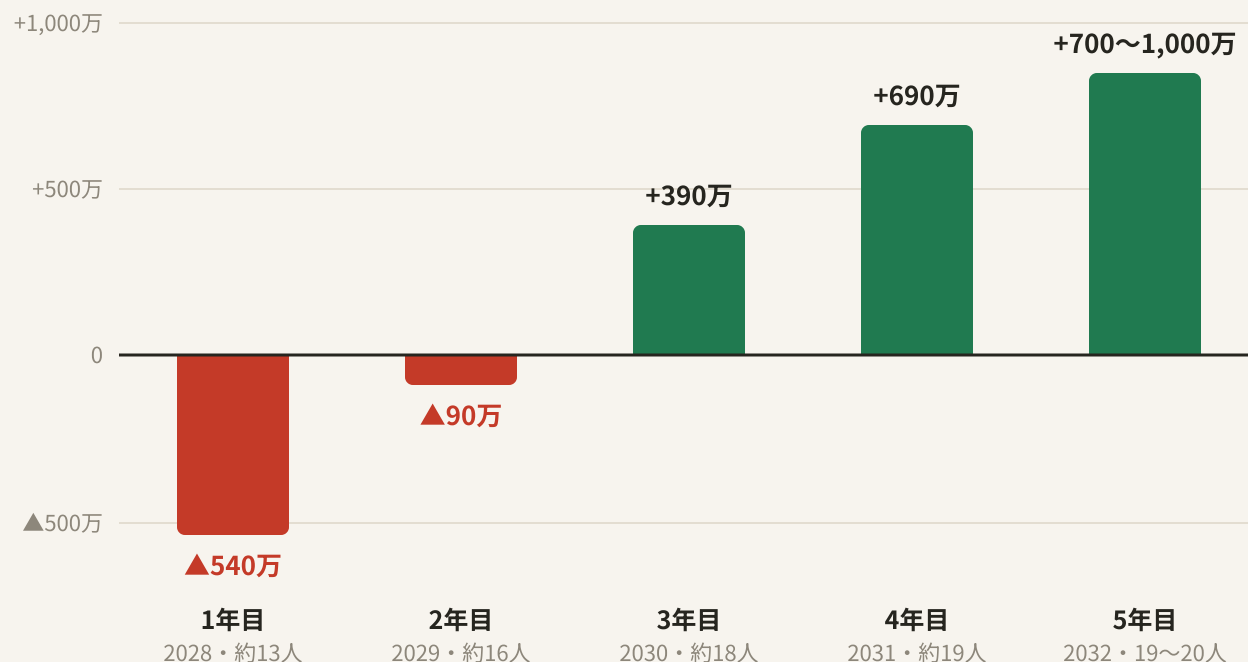
+ 運転資金1億1,000万円(BEP到達まで2年分)を別途確保
Phase 1で運営実績・入居パイプラインを確認した上で、Phase 2の受入を拡大する

※建設投資は一括となるため、圏域6病院との連携による入居予約で稼働立ち上げリスクを抑制する

だから何？ 受入と人員配置の段階化で運営リスクが逡減する

開設後5年の収支見通し

年間損益の推移(概算・万円)



段階受入と開設時からの高水準給与を前提とした保守的な想定。開設3年目に損益分岐を超える。

1～2年目の資金流出(累計▲約630万円+開設前の採用・研修費用)は運転資金1億1,000万円で十分にカバー。

賃金上乘せ・役員報酬(月77万円)を立ち上げ期は業績連動とすれば、2年目黒字化まで短縮できる。

※月次収支モデル(P15)を利用者数別に展開した概算。入居ペースは圏域6病院との連携による紹介を前提

だから何？ 3年目に黒字化。上乘せ分の業績連動化で2年目まで短縮可能

年6,200万円の社会的コスト削減

入院からGHへの移行1人あたり:月26万円 × 12ヶ月 = 年309万円の公費削減。

20名満室の場合:309万円 × 20人 = 年間6,180万円(約6,200万円)の公費削減。

年309万円/人

入院→GH移行による公費削減

年6,200万円

20名分の年間公費削減額

投資額3.9億円に対して、毎年6,200万円の社会的リターンを生む。この事業への出資は、そのまま公費削減に直結する。

だから何？ 出資 = 公費削減。社会的リターンが明確

波及効果—— 経済的リターンを超えた価値

個人 病院ではなく「自分の部屋」で暮らす。鍵のかかる個室。自炊もできる。人間の尊厳の回復

地域 20名の生活消費が地域経済に還流。日用品・食材・交通・医療の地域内消費

医療 病床の回転率向上。急性期治療を必要とする患者への病床再配分が可能に

財政 年6,200万円の公費削減。削減された財源を他の福祉施策に転用可能

雇用 常勤6名+パート2名+夜勤ローテ(最大5名/晩)を地域トップ水準の処遇で雇用。福祉人材のキャリアパスを提供

だから何？ 経済的リターンを超えた、多層的な社会的価値を生む

拡張計画——日立から茨城全域へ

第1号は日立市内での展開。成功モデルが確立されれば、日立障害福祉圏の他市(高萩市・北茨城市)、さらに茨城県内他圏域への横展開が可能。

日立市 vs 高萩市 比較評価

評価軸	重み	日立市	高萩市
市場規模	25%	12,944人 ◎	~1,508人 △
GH需要見込	20%	454人 ◎	77人 △
需給ギャップ	20%	供給不足確定 ◎	需要未到達 ○
自治体の姿勢	15%	新規参入促進 ◎	成果目標のみ ○
競合環境	10%	26事業所 ○	少数 ◎
土地コスト	10%	3~8万/坪 △	1.5~4万/坪 ◎
加重スコア	100%	4.30	2.75

第1号は日立市。高萩市は第2号以降の候補

だから何？ 拡張モデルへの投資。成功すれば横展開できる

リスク管理と対策

想定されるリスクとその対策。すべてのリスクに具体的な緩和策を準備。

リスク	影響度	対策
入居者不足	高	供給不足(達成率112%)+年金内で払える家賃3万円で障壁を低減。段階受入+運転資金2年分
人材確保困難	低	地域トップ水準の給与(サビ管50万円/月等)+仮眠対応スタッフルームで差別化
建設コスト増	中	RC造は複数社見積・設計VEで抑制。予備費を計上
報酬改定	中	実費収入が月間収入の28.3%。感度分析で耐性確認済み
回収長期化	高	満室維持が前提。賃金上乘せ・役員報酬の業績連動化で調整余地。RC造47年の資産が残存
競合参入	低	+115人の成長余地で20人を吸収。RC造×夜間体制の差別化で優位

だから何？ 主要リスクへの備えが具体的。想定外を最小化

資金使途——必要初期費用3億8,570万円

本計画は「必要な初期費用の総額」として提示。資金調達の内訳は別途協議。

区分	金額	備考
土地取得(250坪)	2,500万円	坪単価10万円
建築費(1棟・延床約800㎡)	2億2,300万円	RC造3階建て・全室1K仕様・坪単価約92万円
付帯工事	1,000万円	外構・駐車場
消防設備	1,000万円	6項目対応
家具・備品(居室20室+大型キッチン厨房設備)	500万円	20名分調理対応
建設関連 小計	2億7,300万円	
開業費用	270万円	法人設立・車両等
運転資金(2年分)	1億1,000万円	BEP到達まで(高水準給与ベース)
必要初期費用 合計	3億8,570万円	約3.9億円

調達は出資・金融機関借入・公的融資(独立行政法人福祉医療機構等)の組合せを想定し、詳細は協議の上決定。自治体の施設整備補助の活用可能性も精査する。

だから何？ お金の使い道が透明。全額の使途が明確

— CONCLUSION

だから今、出資する価値がある

社会的意義	18万人の社会的入院。住む場所さえあれば退院できる人々に「家」を提供する
公費削減	20名で年6,200万円の公費削減。出資がそのまま社会的リターンになる
市場の裏付け	GH達成率112%。需要が供給を常に上回る日立市に、データに基づいて参入
安全設計	段階受入。運転資金2年分。賃金・役員報酬は業績連動で調整可能。RC造47年の資産が残る
実行体制	圏域6病院全院訪問済み。相談支援事業所との連携確立。行政が参入を促進

NEXT STEPS — ① 詳細財務モデル・算定根拠の開示 ② 土地候補の現地確認 ③ 行政・病院ヒアリングへの同席 ④ 出資条件・スキームの協議